

ICUの終末期と意思決定

DNARは心停止時だけ、決め方は4観点とSDM、終了するなら苦痛に先回りする — なぜ大事か・言葉をそろえる・誰がどう決めるか・どう話すか・差し控え／終了／TLTの選び方・緩和的抜管・看取りと死別（死の判定・臓器提供）・チームのケア・落とし穴

聖路加国際病院 集中治療科

対象：研修医・専攻医・看護師

最終更新 2026-10-11

ICUで亡くなる患者の多くは、治療を「どこまで続けるか」を決めた後に亡くなります。決め方を誤ると、本人の望まない治療が続くか、救えたかもしれない治療が最初から差し控えられます。この資料で持ち帰るのは、①DNARで決まるのは心停止時の蘇生だけで、治療の範囲は「終末期かどうか」ではなく多職種の4観点の検討と共同意思決定（SDM）で決め、迷えば期限付きの試行（TLT）にする、②面談は価値観を聴いてから推奨を伝え、決定の重荷を家族に負わせない、③終了するときは緩和ケアを先に準備し、抜管の前後の苦痛に薬で先回りして、家族とチームを支える、の3点です。

✓ 要点 — この資料の骨格

日本の基準線は、2026年9月の4学会合同ガイドライン（日本集中治療医学会・日本救急医学会・日本循環器学会・日本緩和医療学会）です [4学会GL2026]。終末期を定義せず手順で決め、差し控えと終了を倫理的に同等とし、緩和ケア別編で抜管時の薬まで示しました。この資料はその骨格に、面談・家族支援・死の判定・チームのケアの研究を重ねたものです。ガイドラインの手順・薬の使い方・Q&Aの要点は解説ページ「[生命維持治療の終了と差し控え — 4学会合同ガイドライン2026](#)」（要点だけなら[2ページの要約](#)）に、全文は原典「救急・集中治療における生命維持治療の終了／差し控えに関する4学会合同ガイドライン」（2026）にあります。

§1 なぜ大事か — ICUの死の多くは「決めた後」に起き、日本は終了をためらってきた

欧州では治療を制限した後の死が9割に達し、治療制限は例外ではなく標準になりました。日本では「一度始めたらやめられない」という不安が強く、終了より差し控えが選ばれてきました。この章では、その背景と、2026年に引き直された基準線を確認します。

この章のポイント

- 1 治療制限は看取りの開始ではなく、ゴールの定義し直しと知る
- 2 「やめられないから始めない」をしない
- 3 4学会GL（2026）の手順を判断の基準線にする

1-1. 治療制限は例外から標準になり、制限後に生きて退院する人も増えた

欧州22 ICUを16年あけて比べたEthicus-2では、治療制限を伴う死が68.3%から89.7%へ増え、治療制限を受けた患者の生存退院は5.5%から20.4%上がりました（表1） [Ethicus-2 JAMA2019]。

治療制限は「看取りの開始」ではなく、「治療のゴールを定義し直す行為」です。差し控えた後に限れば生存退院は8.9%から34.9%に上がっています [Ethicus-2 JAMA2019]。一方で、終了（withdraw）の後は24時間以内に98%が亡くなっており、差し控えと終了は臨床的にはまったく違う経過をたどります。

表1 | Ethicus-2（1999→2016、欧州22 ICU） — 制限は標準になり、制限後の生存も増えた

指標	1999～2000年	2015～2016年	読み方
治療制限を伴う死	68.3%	89.7%	差21.4%（95%CI 19.2～23.6）
制限なしのまま亡くなった患者	31.7%	10.3%	フルコードでの死は少数派に
治療制限後の生存退院	5.5%	20.4%	制限は死の決定ではない
差し控え後の生存退院	8.9%	34.9%	差し控えた3人に1人は退院
終了後24時間以内の死亡	—	98%	家族の到着・別れの調整は決定の前に

対象は西欧に偏った22 ICUで、そのまま日本に当てはまるとは限りません [Ethicus-2 JAMA2019]。

1-2. 日本では「やめられないから始めない」が初期治療をためらわせてきた

2014年の3学会ガイドラインは人工呼吸器を含む生命維持装置の終了を認めていましたが、法的リスクの不安と、終了後の緩和ケアの指針がないことから終了はほとんど行われず、「やめられないなら最初から始めない」という判断が救命できたかもしれない患者の治療をためらわせる危険がありました [4学会GL2026 説明文]。

旧版は「終末期」を4つの例示で定義し、旧Q&Aは「近いうち」をおおよそ2～3日以内としていました。その結果、生命維持治療を続けている限り終末期にならず、望まない治療が死の直前まで続く運用が残りました [4学会GL2026 説明文]。日本では「欧米ではICUの死の多くが終了の後に起こるが、日本には終了から死までを管理するプロトコルがない」ことも、踏み切れない実質的な理由だと指摘されています [伊藤 人工呼吸2023]。

1-3. 2026年の基準線 — 終末期を定義せず、手順で決める

4学会合同ガイドラインは「終末期」をあえて定義せず、多職種の臨床倫理的検討と厚労省プロセスガイドラインに沿ったSDMという手順を示し、差し控えと終了を倫理的に同等とし、DNARは心停止時の蘇生に限ると明文化しました（表2） [4学会GL2026]。

表2 | 2014年版から2026年版で変わったこと — 結論ではなく、決め方を示す

項目	2014年版（3学会の提言）	2026年版（4学会合同GL）
終末期	定義し、4つの例示	あえて定義しない。病態は「医学的側面」として個別に評価
判断の枠組み	医療チームが終末期と判断	多職種の臨床倫理的検討（4観点）+SDM（§3）
差し控えと終了	—	倫理的に同等（§5）
TLT	記載なし	明記。一度始めた治療もやめられる
緩和ケア	「緩和的措置」の一言	緩和ケア別編で薬・用量・家族ケア・医療者ケア（§6・§7）
用語	延命措置・中止	生命維持治療・終了。「消極的安楽死」「BSC」は使わない
作り方	記載なし	修正デルファイ法（3ラウンド）+パブリックコメント。推奨の強さは付かない

1-4. 法律はないが、手順を守ることが法的な不安への答えになる

日本には終了・差し控えを定めた法律がなく、判例と、厚労省プロセスガイドラインや学会ガイドラインという soft law が拠り所で、2007年以降、救急・集中治療の終末期医療で全国報道された刑事事件や警察の介入は確認されていません

[4学会GL2026 説明文]。

有罪になった2件（東海大学病院事件・川崎協同病院事件）は、塩化カリウムや筋弛緩薬で死期を早めた事例でした。不起訴の2件は意図的な行為はなかったものの、許容される終了かどうかが不明瞭で警察の介入を招いています [4学会GL2026 説明文]。ガイドラインに沿った適切なプロセスなら、終了・差し控えが刑事裁判で違法とされることはないと考えられる、と説明文は述べています。ただし、従えば法的に免責されるとは書いていません [4学会GL2026 Q48]。

根拠を見る（表3：4つの事件）

表3 | 終末期医療をめぐる4つの事件 — 分かれ目は意図的に死期を早めたかどうか

事件	何をしたか	結果
東海大学病院事件 (1991)	多発性骨髄腫の末期。家族の求めで治療を外した後、ベラパミルと塩化カリウムを静注	1995年 殺人罪で有罪。傍論で治療終了の許容要件（死が避けられない末期状態・本人の意思表示）を示した
川崎協同病院事件 (1998)	心停止後の昏睡。家族の求めで抜管し、苦悶様呼吸に鎮静薬、さらに筋弛緩薬を投与	2009年 最高裁で有罪確定。推定意思に基づく終了が許される場合を認め、末期状態に限定しないと解しうる
射水市民病院事件 (2000～2005)	終末期のがん等の患者7名の人工呼吸器を外した	2009年 不起訴（死期を早める行為ではない、殺意なし）
道立羽幌病院事件 (2004)	本人の意思確認なく、家族への説明も不十分のまま人工呼吸器を外した	因果関係が認められず不起訴

§2 言葉をそろえる — DNARは心停止時だけ、GOCは価値観から

終末期の議論が壊れる原因の多くは、言葉の意味のずれです。なかでもDNARの拡大解釈は日本で最も多い誤りで、学会が名指しで警告しています。この章で、議論の前提になる言葉をそろえます。

この章のポイント

- 1 DNARを理由に、心停止前の治療を自動的に控えない
- 2 「中止」ではなく「終了」と言い、BSCを使わない
- 3 GOCは介入の可否ではなく、価値観から話す

2-1. DNARで決まるのは、心停止したときの蘇生だけ

DNARは「心停止時に心肺蘇生を行わない」という限定的な指示で、胸骨圧迫・除細動・気管挿管などの心停止時の処置に限られ、抗菌薬・酸素・非侵襲的換気・鎮痛鎮静・補液はDNARの有無にかかわらず行います（図1） [4学会GL2026 Q37]

[日本救急医学会2025]。

DNARの指示で決まっていること

心停止したとき



胸骨圧迫・除細動・気管挿管などの蘇生を行わない

DNARでは何も決まっていないこと（別に話し合う）

心停止の前の治療



挿管・人工呼吸・昇圧薬・血液浄化・輸血・ICU入室は、目標と価値観に照らして一つずつ決める

症状を和らげる治療



抗菌薬・酸素・非侵襲的換気・鎮痛鎮静・補液はDNARの有無にかかわらず行う

してはいけない運用

一律・便宜的なDNAR



入院時の一律設定、業務効率や急変対応の簡略化のための設定

partial DNAR



「胸骨圧迫はするが挿管はしない」のような曖昧な指示

4学会GL2026のQ37・Q39、日本救急医学会の用語の統一概念（2025）、日本集中治療医学会の勧告（2017）に基づく

図1. DNARの射程 — 決まっているのは心停止時の蘇生だけ。

図の読み方 — 一番上の段だけがDNARで決まっていることで、真ん中の2段はDNARでは何も決まっていない領域です [日本救急医学会2025]。いちばん多い誤りは、真ん中の段まで「DNARだからやらない」と読み替えることです。下の赤い段は、4学会GLが明確に否定した運用です [4学会GL2026 Q39]。

日本集中治療医学会は2017年に、DNAR指示のもとで酸素投与・気管挿管・人工呼吸器・補助循環・血液浄化・昇圧薬・抗菌薬・輸液・栄養・鎮痛鎮静・ICU入室などを自動的に差し控えてはならず、DNARのマニュアルと終末期医療のマニュアルは分けて作ることが強く推奨されるとしました [日本集中治療医学会2017]。日本救急医学会の用語の統一概念（2025）も、「DNARを取る」という言い方と、DNARを理由に心停止前の挿管や人工呼吸を行わない誤認を名指して正しています [日本救急医学会2025]。

この誤りは個人の勉強不足より、様式の設計の問題です。22研究を統合したナラティブレビューは、DNAR指示の範囲が紙の上で定義されていない限り、現場の解釈は必ずばらつくと説明しています [Khayat Kakhki ResuscPlus2026]。

2-2. 言葉の対応表 — 厳密な言葉を、都合のよい婉曲表現にしない

DNARを「治療全般を控える」、GOCを「予後不良」、BSCを「緩和ケア」の言い換えに使うと、元の意味とのずれが記録にも会話にも残らないので、議論の前に表4で言葉をそろえます [4学会GL2026 説明文] [Secunda JGIM2020]。

表4 | 言葉の正しい意味とよくある誤解 — 議論の前に言葉をそろえる

用語	正しい意味	よくある誤解・使わない理由
生命維持治療	生命を維持するのに必要とみなす治療。昇圧薬・ペースメーカー・人工栄養・水分補給・透析・輸血・輸液も状況によって含まれる	人工呼吸器と補助循環だけだと思う
差し控え／終了	始めない／始めたものをやめる。倫理的に同等	「中止」は再開も含みうるので「終了」と言う。「消極的安楽死」とは呼ばない
DNAR	心停止時に蘇生を行わない指示。心停止時のみ有効	「治療全般を控える」ではない。「DNARを取る」も誤用
Goals of Care (GOC)	本人の価値観と優先順位に基づき、介入を使うか控えるかの判断を導く医療の包括的な目標	DNARや人工呼吸の可否リストではない。「予後不良」の婉曲表現でもない
意思決定能力	選択を伝える・理解する・自分のこととして認識する・比較して考える、の4過程を決定ごとに評価する臨床判断	診断名・認知機能の点数・「医師の勧めに従うか」では決まらない
TLT	目標と期間を合意して治療を試し、期限で必ず見直す取り決め	「とりあえず様子見」ではない。期限で自動的に終了もしない
BSC	本来はがん臨床試験で両群に等しく行う最低限の医療	中身が見えず「見放した」と受け取られるので、4学会GLは使わないと決めた。代わりに続ける・控える・終える治療を書く（ 解説ページの1-4 ）
スローコード	形だけ・手加減した蘇生	「家族への配慮」ではなく欺瞞（§5-4）

2-3. GOCは4要素で — 最初に価値観、最後に介入

1987～2018年の文献214本を分析した系統的レビューは、GOCを①包括的な目標 ②本人の価値観と優先順位 ③臨床的な文脈 ④介入の判断を導く、の4要素がそろったものと定義し、この順序を崩すと面談は「DNARを取る場」に退行します（表5）

[Secunda JGIM2020]。

表5 | Goals of Careの4要素 — 順序が本体

要素	内容	面談での位置
①包括的な目標	延命か快適さかの二択ではなく、複数の目標を同時に追ってよい	最初に聞く
②本人の価値観と優先順位	何を大切にしてきたか。自宅に帰る・自分でできる・家族の行事など	最初に聞く
③臨床的な文脈	今の病状で何が可能か。可逆性と予後の見立て	次に説明する
④介入の判断を導く	③を踏まえ、②に沿う介入は何かを一緒に考える	最後に話す

実際の面談では、医師が「ゴールの話をする」と宣言した場面でも、発話の4%未満しか本人の意向や価値観に触れていませんでした [Secunda JGIM2020]。カルテでも「GOC=DNAR」と省略せず、「本人が大切にしていること」「今の文脈での実現可能性」「そこから導かれる方針」を分けて書きます。

ここで使う言い方

「すべてやりますか、やめますか」ではなく、「〇〇さんがこれまで一番大切にされてきたことは何でしょうか」から入ります。4学会GLの緩和ケア別編は、「これができないまま生きていくのは考えられない、と思うのはどんなことですか」という問いを例に挙げています [4学会GL2026 別編]。

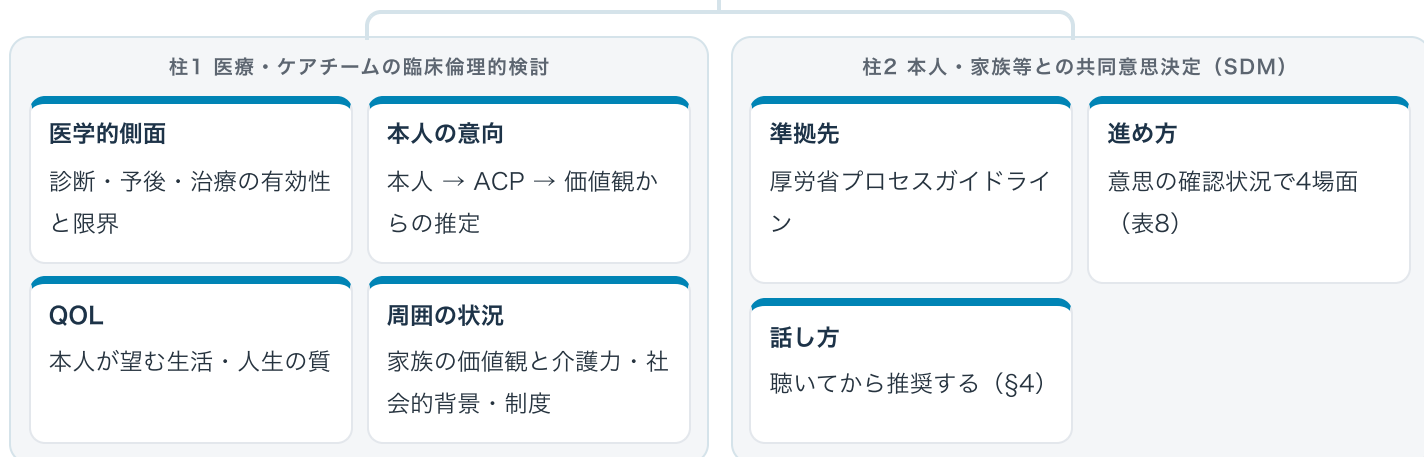
§3 誰がどう決めるか — 多職種の4観点とSDMの2本柱で、一人で決めない

決めるのは担当医一人でも、家族一人でもありません。医療・ケアチームが4つの観点で検討し、本人・家族等と話し合っ一緒に決めます。この章では、その手順と、評価の過程に紛れ込む予測や先入観の扱い方を見ます。

この章のポイント

- 1 4観点を多職種で話し、全員に発言の機会を保証する
- 2 意思決定能力は決定ごとに4過程で評価する
- 3 予測と決定を分け、違和感と先入観を点検する

生命維持治療が大きな苦痛を伴うのに、本人の望む結果につながらないと考えられる（誰が提起してもよい）



対応は3つ → 差し控え／終了（症状緩和のみ、または一部）／期限付きの試行（TLT）。どれでも緩和ケアを並行する（§5）

決まらないとき → 臨床倫理コンサルテーション・臨床倫理委員会に助言を求める。決定は代行しない

4学会GL2026 本編 I-1 と付録3をもとに作図

図2. 生命維持治療の終了・差し控えを決める手順 — 2本柱で検討し、3つの対応から選ぶ。

図の読み方 — 上のきっかけから、左のチーム内の検討と右の本人・家族との話し合いを並行して進めます [4学会GL2026]。下の青い帯が選べる対応、最後の帯がどちらかの柱で合意できないときの相談先です。

3-1. チームの検討は4観点をもれなく、全員に発言の機会を

臨床倫理的な検討とは医学的側面・本人の意向・QOL・周囲の状況の4観点をもれなく話すことで、その患者に関わるすべての診療科と多職種、かかりつけ医や在宅の医療・ケア従事者まで加わり、全員に公平な発言の機会と心理的安全性を保証します（表6）

[4学会GL2026]。

表6 | 臨床倫理的検討の4観点 — 医療者の偏見を外して、もれなく

観点	検討する内容
医学的側面	診断・予後・治療の有効性と限界を客観的に評価する。各疾患の専門家の見解を踏まえる
本人の意向	意思を示せば十分な説明を受けたうえでの意向。示せなければACPの記録（事前指示書を含む）。それ も無ければ価値観から推定する
QOL	本人の望む生活・人生の質を知り、どう担保するかを検討する
周囲の状況	家族の価値観と介護力、社会的・文化的背景、法制度・病院体制を把握し、必要な社会的支援を考える

「多職種カンファ」の実態は理想から遠いことがあります。フランスのICUで差し控えを議論するカンファを実測したところ、実質14分のうち医師が94%を話し、看護師・看護助手の発言は1分（5%）でした [Tarcy ICM2022]。司会が発言を明示的に他職種へ振り、患者の情報は事前に共有して、その場は議論に使います。医師の方針を追認するだけの形式的な場は、4学会GLの趣旨に反します（Q62） [4学会GL2026]。

3-2. 意思決定能力は、決定ごとに4つの過程で評価する

意思決定能力は、選択を伝えられる・理解できる・自分のこととして認識できる・比較して考えられる、の4過程をその決定について評価する臨床判断で、診断名や認知機能検査の点数では代用できません（表7） [Ganzini JAMDA2004]。

表7 | 意思決定能力の評価 — 何が本体で、何が代用にならないか

方法	使い方	根拠・注意
4過程の評価	これが本体	担当する臨床医が行い、最終責任を持つ
説明の有無の確認	先に確かめる	情報が与えられていないことは能力の欠如ではない
時間軸の確認	忘れやすい	欠如はしばしば一時的。回復が見込めれば決定を待ち、回復したら本人に戻す。鎮静薬や挿管で低下して見えることもある
認知機能検査（MMSE など）	代用にならない	高得点でも能力を欠く人、低得点でも一部の決定ができる人がいる
診断名（認知症・統合失調症など）	単独では否定できない	欠如の最多の原因はせん妄と認知症だが、能力が保たれていることも多い
「医師の勧めに従うか」	根拠にならない	助言に反したことは能力欠如の根拠ではない

カルテには「意思決定能力なし」と書かず、「〇月〇日〇時、△△の同意について、4つの過程のうち□□が確認できなかった」と、決定・時刻・欠けた過程を書きます [Ganzini JAMDA2004]。4学会GLも、説明の工夫や環境の調整で能力をできる限り引き出すよう求め、能力が十分でなくても本人が価値観や選好を持っていることは多いとしています（Q16） [4学会GL2026]。

3-3. SDMは、本人の意思にどこまで近づけるかで4つに分ける

本人の意思を確認できるか、推定できるか、推定もできないか、家族等がいなくて進め方を変え、どの場面でも「最善」は第三者が決める利益ではなく本人の価値観に即した最善で判断します（表8） [4学会GL2026]。

表8 | SDMの4つの場面 — 「あなたならどうするか」ではなく「ご本人ならどう言うか」

場面	進め方
本人の意思を確認できる	能力を評価し、説明して合意する。能力がなくても、それまでのACPが今の状況に当てはまれば尊重する
確認できないが推定できる	家族等とチームが推定した意思を尊重する。ACPの状況が今と違って、希望や価値観は推定の根拠になる
推定もできない	家族等と十分に話し合い、本人にとって最善の方針をとる。状態や評価が変わるたびに繰り返す
身元不詳・身寄りがいない	年齢や外見の偏見を排し、過去の意向を最大限尊重する。終了・差し控えはチームや臨床倫理委員会が公正で透明な手続きで判断する

家族等は法的親族に限らず、本人の価値観をよく知る人で、友人や事実上のパートナーも含み、複数でもかまいません（Q5・Q50）。複数いるとき・いないときの考え方は[解説ページの2-4](#)。家族の意向に介護や経済的な負担、年金などの事情が影響していないかにも注意し、優先するのは本人の価値観です（Q6・Q18） [4学会GL2026]。代理で決める家族の理解には偏りがあり、前向き研究では代理意思決定者の19%がICU医療をほとんど理解しておらず、ほぼ半数がケアの内容をよく知らないまま重い決定に関わっていました [Jabaley CritCare2026]。一度に大量の情報を渡すより、段階的に確かめながら進めます。

表9 | 迷う場面の次の一手（4学会GL2026のQ&Aから） — 一度で決めきらず、一人に背負わせない

場面	確かめること	次の一手
本人と家族の意見が違ふ	家族の意向に介護・経済的負担や年金の事情が影響していないか	本人の価値観を中心に調整し、必要なら第三者の助言を求める（Q6・Q18）
「お任せします」と言われる	情報の差が原因ではないか	専門用語を避け、選択肢と利点・不利益を釣り合いよく示して理解を確かめる（Q19）
意思が揺れる	揺れは自然なこと	再面談と再評価を前提にし、家族に強い決断力を求めない（Q20・Q21・Q29）
本人が終了を希望する	自己決定だけに依拠していないか	医学的妥当性を含む検討とSDMで総合的に判断する（Q54）
公的支援とつながらない孤立した患者	診療記録・生活歴・知人や関係機関	医療ソーシャルワーカーと連携し、単独で判断しない（Q27）

3-4. 予後の数字は「情報」、決定は価値観で — 予測と決定を分ける

予後モデルに基づいて治療の縮小や終了を決めることは医療者の倫理的責任が禁じると明言されており、重症度スコアを治療制限の理由としてカルテに書かず、予測は家族と共有する情報、決定は価値観と合意で行います [Bein ICM2023]。

「偽陽性ゼロ」という報告も、分母を見て伝えます。心停止後の神経予後予測で「不良マーカー2つ以上なら偽陽性ゼロ」とされた研究は良好転帰が33例しかなく、rule of three (0/nの95%上限はおよそ3/n) により、真の偽陽性率は95%の確からしさで10.6%以下としか言えません [Xu CritCare2026]。家族には「外れたことがない」ではなく「10人に1人まで外れうる不確実さが残る」と伝え、時点を固定して再評価します。「反応がない」も「意識がない」と同じではありません。行動上は反応のない急性脳損傷患者の15～25%には、脳波やfMRIでしか検出できない隠れた意識 (covert consciousness) があり、それがあ患者では12か月後に自立まで回復した割合が44%対14%と高くなります [Egawa JIntensiveCare2024]。家族にはこの一文をそのまま伝え、72時間以内の断定を避けて、時間をおいて繰り返し評価してから話し合いを進めます。予後予測が治療の終了を通じて自らの予測を的中させる「自己成就的予言」の議論は、[心停止後ケアの5-4](#)に譲ります。

3-5. 複数の医療者の「不適切な治療では」という違和感は、予後のシグナル

オランダ47 ICUの医療者1,058人の26%が調査当日に「不適切な医療を提供している」と感じており、複数の医療者が同じ患者について一致して報告した場合、その患者の6か月死亡は3.86倍 (95%CI 1.23～12.16) でした [PICNL-ICU CCM2026]。

理由の首位は分配的正義 (70%)、次いで治療量と期待される転帰の不釣り合い (66%) でした。1人だけの報告では有意な関連はありません [PICNL-ICU CCM2026]。現場の違和感を個人の感情として流さず、複数人の一致を拾う仕組みを持つことが、この研究の実務的な結論です。

3-6. 「この人はどうせ」という先入観を点検する

障害のある人を無自覚に価値が低いものとして扱う前提 (エイブリズム) は、自律尊重・善行・無危害・公正という誰も反対しない4原則を、歪んだまま治療制限の正当化に使わせず (表10) [Taccone ICM2023]。

表10 | 先入観が評価を歪める3つの経路 — 障害は能力の欠如を意味しない

経路	起きること	点検の問い
自律性の否定	家族や医療者が「この人の最善は自分たちが知っている」と想定する	本人に直接、その決定について聞いたか
合理的配慮の欠如	伝えられない苦痛が興奮と読み替えられ、鎮静で処理される	文字盤・筆談・タブレットなどの補助具を試したか
知識の欠如	障害を「終末期」「一律にQOLが低い状態」と誤認し、公正を持ち出して治療を絞る	同じ病状で障害のない人にも同じ基準を当てるか

医療者の推定するQOLはあてになりません。脊髄損傷の調査では、重度の損傷を負っても生きていてよかったと思うと答えた救急医療者は18%でしたが、実際の生存者本人は92%が「生きていてよかった」と答えていました [Gerhart AnnEmergMed1994]。4学会GL

も、障がいの有無や医療機器の使用だけを理由に終了・差し控えを検討することはなく、外見や機能からQOLや価値を推し量らないと明言しています（Q70～Q76） [4学会GL2026]。高齢・フレイルの患者の判断は**フレイルと高齢重症患者**の資料で扱います。

3-7. 決まらなければ臨床倫理コンサルへ — 対立はまず層を見立てる

チームでゴールが決まらない、本人・家族と合意できない、家族の中でまとまらない、意思が分からず家族もいないときは、臨床倫理コンサルテーションや臨床倫理委員会に助言を求めますが、決定は代行されず、チームと本人・家族等に残ります [4学会GL2026]。

「困った家族」というラベルを貼る前に、対立がどの層にあるかを見立てます。課題（何をすべきか）、プロセス（誰がどう決めたか）、関係（信頼と敬意が壊れたか）の3層で、「困った家族」の多くはプロセスの不全から生まれ、関係の層に入ると解決は格段に難しくなります（表11） [Jabaley CritCare2026]。4学会GLの緩和ケア別編も、対立は価値観の違いよりコミュニケーション不足から生じることが多く、話し合いを重ねれば90%以上の事例で合意に至ると述べています [4学会GL2026 別編]。

表11 | 対立の3層 — 層を見誤ると打ち手も外れる

層	問われていること	典型的なことば	打ち手
課題	何をすべきか	「透析は続けるべきだ」	情報の共有と選択肢の整理
プロセス	誰がどう決めたか	「そんな話、聞いていません」	決め方と決定者を明らかにする
関係	信頼と敬意が壊れたか	「この病院は信用できない」	調停・第三者の関与。だから手前で止める

臨床倫理委員会は、適切なプロセスを踏んだ決定であれば、刑事・民事で訴追されたときにチームを守る役割を持つとされ、医療安全委員会とは独立して運用するのが望ましいとされます（注釈2・Q61） [4学会GL2026]。

§4 どう話すか — 聴いてから推奨し、決定の重荷を家族に負わせない

決め方の手順が正しくても、話し方を誤れば家族には「決めさせられた」という傷が残ります。この章では、深刻な知らせを受け取る脳の状態から始め、面談の型、公式面談と日々の対話の使い分け、家族支援の研究が教えることを見ます。

この章のポイント

- 1 悪い知らせの直後に決定を求めない
- 2 理解と大切なことを聴いてから、推奨を伝える
- 3 「決めたのはご家族です」と言わない

4-1. 深刻な知らせの直後、家族の脳は意味を受け取れない

言葉の意味が届くより先に扁桃体と島皮質が「危険」を登録し、カテコラミンとコルチゾールが注意を狭めて作業記憶を止めるので、沈黙・怒り・無反応は「理解の悪さ」ではなく生理的な過負荷のサインです [Rusinova ICM2026]。

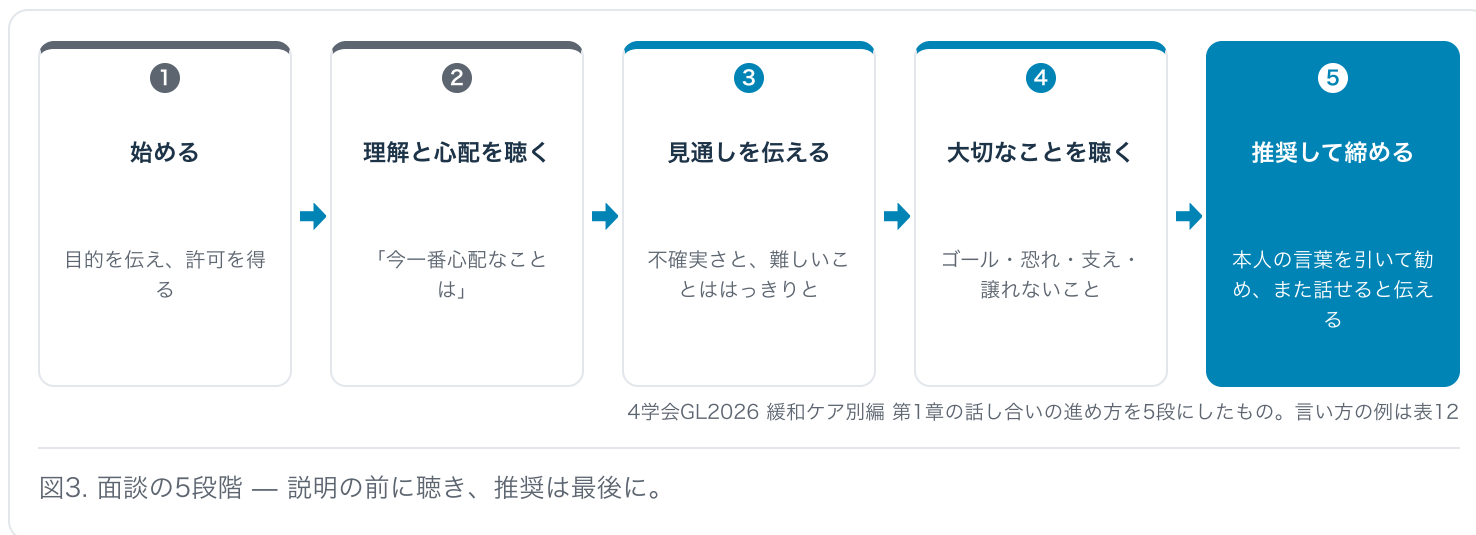
知らせを伝えるときの3つの約束

- 1 その時間帯に重要な決定を求めない。「では、どうされますか」を告知の直後に置かない
- 2 見出しは1文で短く直接に伝え、意図して間を置く
- 3 「わかりましたか」ではなく「ここまでで受け取られたことを教えてください」と聞き、返ってきた言葉をカルテに書く

静かな個室・全員分の椅子・手の届くティッシュはケアの前提ですが、個室そのものが「悪い知らせを聞く部屋」として記憶され、避けたい場所になる家族もいます [Maringer ICM2018]。

4-2. 面談の型 — 許可を得る、聴く、見通しを伝える、大切なことを聴く、推奨する

4学会GLの緩和ケア別編は、目的を伝えて許可を得る、理解と心配を聴く、見通しを伝える、大切なことを聴く、本人の言葉を使って推奨を伝える、の5段階を示し、医療側が一方的に説明を始めないことを要にしています（図3） [4学会GL2026 別編]。



図の読み方 — 灰色の2段は医療者が話す前に相手の受け止めを知る段です [4学会GL2026 別編]。病状の共有 → 価値観 → 医療チームの推奨、という3段階の枠組み（3ステージプロトコル）とも同じ順序です

[Lu MayoClinProc2020]。

表12 | 面談の言い方の例 — 本人の言葉を拾って、推奨につなげる

段階	言い方の例（4学会GL2026 緩和ケア別編）
始める	「今後予想されることをお伝えし、あなたにとってどのようなことが大切かをお聞きしながら、これからの治療やケアの方向性について一緒に考えていきたいと思うのですが、よろしいでしょうか？」
理解と心配を聴く	「今一番心配になられていることはどのようなことですか？」「病状について、どのようにとらえておられますか？」
見通しを伝える	「そうでないといいのですが、残された時間が日単位～週単位くらいになってきている可能性があることを心配しています」
大切なことを聴く	「普段の生活で一番楽しみにしていることはなんですか？」「もしお話しすることが難しくなった場合、あなたに、あなたの意思を推定して話し合ってほしいですか？」
推奨して締める	「〇〇がとても大切だとおっしゃいましたね。それを考慮に入ると、現在の病状では◎◎をお勧めします」「この方針をどう思われますか？」

説明者が正面に座るなら、看護師は本人・家族と説明者の間（90度の位置）に座ります。心情を打ち明けられたら「わかります」と即答せず沈黙を置き、感情にはNURSE（命名・理解・承認・支持・探索）で応じます [4学会GL2026 別編]。悪い知らせの伝え方（SPIKES）も同じ構造です。本人に意識があれば、家族より先に本人に聞きます。死が近いと判断された意識清明な患者の気がかりで最も多かったのは「治療の目標を話し合いたい」でした [Kentish-Barnes ICM2023]。

4-3. 「決めたのはご家族です」ではなく「医学的な結論をご家族と確認しました」

治療の終了に家族が関わると「死のタイミングに自分が関わった」という決定の残滓（decisional residue）が残ることがあり [Choi CritCare2026]、家族のPTSD症状は単一の出来事ではなく、ICU滞在の全体にわたる引き金の積み重なりから生じます [Kentish-Barnes ICM2026]。

3か月時点でPTSD症状のある家族17人への面接では、入室前の生活史から死後の遺体との対面まで、引き金が疾患の軌跡全体に散らばっていました [Kentish-Barnes ICM2026]。終了の説明では、決定の重荷を家族に負わせない言い方を選び、「安楽死ではない」ことも言葉にします。一方、誰がそろってからにするか、何時にするかを家族に選んでもらった経験は、良い記憶として語られていました。

4-4. 公式の面談と、議題のない日々の対話を使い分ける

ICUの医師の役割は医学情報の唯一の供給源から、信頼を築き情報と誤情報の海を家族と一緒に渡る案内人へ移り、節目の公式面談に加えて、議題を決めない短い日々のcheck-inが重視されるようになりました（表13） [Ashana ICM2026]。

表13 | 公式面談と日々のcheck-in — 同じ型でやろうとしない

項目	公式の家族面談	日々のcheck-in
いつ	入室後早期・TLTの期日・方針を変えるとき	毎日、面会のたびに数分
議題	あり。図3の5段階とGOCの4要素を順に踏む	なし。聴くことに徹する
参加者	担当医・担当看護師・主な意思決定者	その場にいる医療者と面会者
出てくること	予後・方針・介入の可否	宿泊費・休業・症状など医療の外の困りごと
記録	説明の内容・理解・同席者・推定意思の根拠 (§5-6)	ソーシャルワーカーなどへつなぐ情報があれば申し送る

家族が訴える満たされないニーズは、意思決定上の葛藤より、患者の症状・経済的な困窮・スピリチュアルな不安のほうが多いと報告されています [Cox CCM2023]。家族面談を、立場の異なる当事者が合意を作る「交渉」の場として捉え直す視点もあります [Tuinman ICM2026]。

4-5. 家族支援の研究 — 専任の伝え役は効かず、死の前後に会うことが効いた

多職種の家族支援（PARTNER）やコミュニケーション・ファシリテーターのRCTは家族の心理症状を減らせませんでした。死に近い患者の家族に死の前・最中・後に医師と看護師が会う3ステップ支援は、6か月後の遷延性悲嘆を21%から15%に減らしました（表14） [Kentish-Barnes Lancet2022]。

表14 | 家族支援の主な試験 — 動いたのは対話の質と、死の前後の関わり

試験	規模	結果	読み方
PARTNER（多職種の家族支援）	1,420例	6か月のHADSは差なし（11.7 vs 12.0）。コミュニケーションの質は改善（69.1 vs 62.7）、ICU滞在は短縮（6.7 vs 7.4日）	心理症状は動かないが、質と資源は動く [White NEJM2018]
コミュニケーション・ファシリテーター	449例	6か月のHADS-うつ差 -0.07	専任の伝え役の新設は行き詰まった [Creutzfeldt CCM2026]
看護師主導の介入（系統的レビュー）	14研究・2,885家族	不安・うつ・PTSDは改善せず、コミュニケーションの質と在院日数が改善	同じ方向の結果 [Li CCM2026]
3ステップ支援（クラスターRCT）	875人・34 ICU	遷延性悲嘆21%→15%（OR 0.6、95%CI 0.4～1.0）	差の実体は死後の面談（対照29% vs 介入85%） [Kentish-Barnes Lancet2022]

3ステップ支援で対照群と最も差が開いたのは、亡くなった後の面談でした。家族カンファや病室訪問は対照群でもおよそ3分の2で行われていたからです [Kentish-Barnes Lancet2022]。一方、お悔やみの手紙は、同じ研究グループのRCTでPTSD・不安・うつの症状

をむしろ増やしました。手を抜くなら手紙ではなく電話にします。

§5 選び方 — 差し控え・終了・TLTは同じ問いへの答え

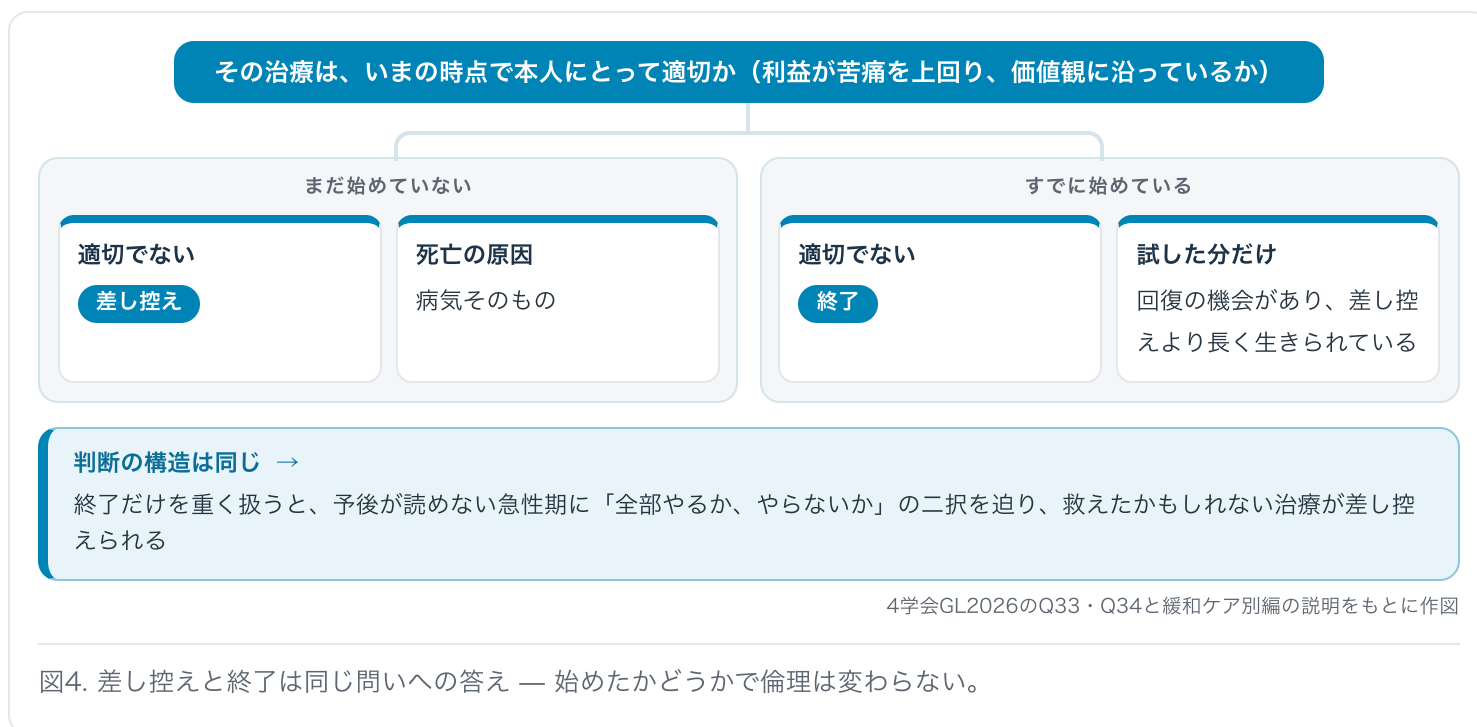
手順を踏んで終了・差し控えが妥当と判断されたら、選べる対応は差し控え・終了・期限付きの試行（TLT）の3つです。どれを選んでも症状緩和は続き、差し控えと終了では心停止時の蘇生は行いません。この章では選び方と、選んだことの記録の仕方を見ます。

この章のポイント

- 1 始めたかどうかで倫理は変わらないと知る
- 2 迷えばTLTにし、目標・期日・価値観を先に書く
- 3 「すべて」は処置に降ろし、スローコードは選ばない

5-1. 差し控えと終了は倫理的に同じ — だから迷ったら始めて試せる

治療の倫理的な評価は始めるか終わるかの順序ではなく「その時点で本人にとって適切か」で決まり、未開始なら差し控え、開始済みなら終了を考えるという判断の構造は同じです（図4） [4学会GL2026 Q33]。



図の読み方 — 上の問いは1つで、左右は治療をすでに始めているかどうかの違いだけです [4学会GL2026 Q33]。一度始めた治療はやめられるので (Q34)、予後が読めないときは始めて試し、期限で見直すことができます (5-3)。

ただし、記録では両者を項目ごとに書き分けます。倫理的には同等でも、生存も死亡までの時間も臨床的にはまったく違うからです (1-1) [Ethicus-2 JAMA2019]。

5-2. 3つの対応で、行うことと行わないことを分けて決める

差し控えは新たな治療の開始や増強をせず、終了は症状緩和だけにするか一部を終了・減弱し、TLTは期間を決めて試し、差し控えと終了ではいずれも心停止時の蘇生を行いません (表15) [4学会GL2026]。

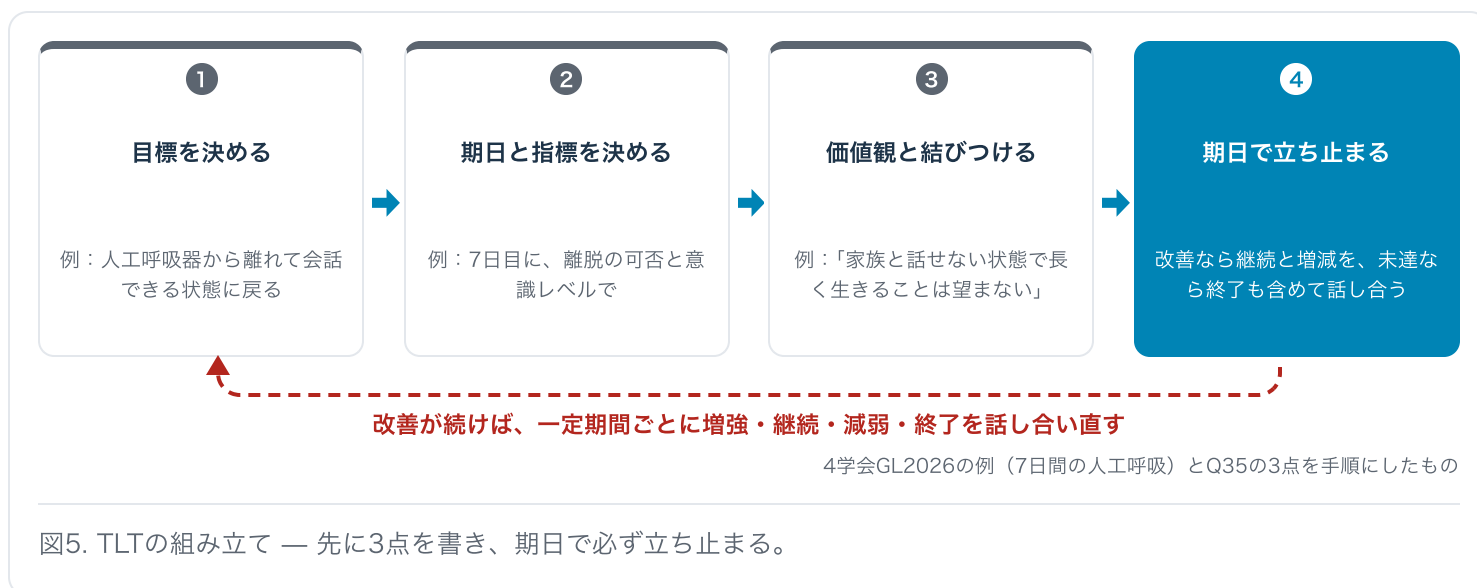
表15 | 3つの対応 — **どれを選んでも症状緩和は最大限続ける**

対応	行うこと	行わないこと
差し控え（不開始を含む）	症状緩和の治療とケア。生命維持装置の設定や昇圧薬は減弱できればする	新たな治療の開始と増強。検査・モニターも侵襲なので最小限に。心停止時の蘇生
終了：症状緩和だけにする	鎮痛・鎮静薬を続けて調整する	人工呼吸器・補助循環・除細動機能は停止か取り外しを検討。血液浄化・昇圧薬・血液製剤・抗菌薬・輸液・人工栄養の終了も検討。心停止時の蘇生
終了：一部を終了・減弱する	項目ごとに続けるか、減らすか、終えるかを決める	心停止時の蘇生
期限付きの試行（TLT）	合意した期間、特定の治療を試し、目標に向かって改善するかを確かめる	期限が来たら自動的に終了すること

4学会GLの作成過程で最も議論が集まったのは「一部を終了または減弱する」（コメント34件）とTLT（31件）でした。現場で判断が最も割れる部分です [4学会GL2026 付録2]。

5-3. TLTは目標・期日・価値観との結びつきを先に書き、期日で必ず立ち止まる

TLTは家族とチームの意見が違うときや予後が読めないときに、目標と期間を合意して治療を試す方法で、始める前に「何を目標に試すか」「いつかで再評価するか」「その結果が本人の価値観とどう結びつくか」を決め、期限で自動終了も自動延長もしません (図5) [4学会GL2026 Q35]。



図の読み方 — 左の3段は始める前に書くこと、右端が期日の判断です [4学会GL2026 Q35]。下の破線は改善したときに話し合いを繰り返す道で、期限が来ても自動的に終了はしません（Q36・Q78）。

面談では、Quillらの5要素（臨床問題と予後の定義・本人の目標と優先順位・改善と悪化の客観的指標・再評価の時間枠・終了時に取る行動）を明示して合意し、フォローアップ面談をその場で予約します [Quill JAMA2011]。TLTは予後の見通しと、家族が状況を受け入れる時間をもたらす一方、侵襲的な治療の期間が延び「死のプロセスの質」を損なう欠点もあります [4学会GL2026]。

！注意 — 「決めきれないから続ける」にしない

3点が曖昧なまま続けると「決めきれないから続ける」「説明が難しいから先送りする」に陥り、ガイドラインの趣旨に反します。多職種で検討したこと自体は結論の正しさを保証せず、判断が本人の価値観とどう整合するかを説明できることが大切です [4学会GL2026 Q35]。TLTの利益とリスクの実証的なエビデンスは乏しく、Quillら自身も「良い実践の提案」と位置づけています [Quill JAMA2011]。

予後が読めない症例では、TLTを特別な場面の道具にせず、初回の面談から「こういう経過なら、こう見直しましょう」と標準の選択肢として先に示しておく、後の再評価がゼロからの交渉になりません [Ashana ICM2026]。

5-4. 「すべてやってください」には処置に降ろして答え、スローコードは選ばない

形だけの蘇生（スローコード）は、米国の倫理文献34本の系統的レビューで82.4%が欺瞞、67.6%が患者への潜在的な害を理由に反対されており、残る選択肢は「目標を共有した全力の蘇生」か「無益の方針に基づく蘇生の辞退」です [Fontenot CCM2026] [Ajzenberg CCM2026]。

「すべて」の中身を、胸骨圧迫・気管挿管・電気ショック・昇圧薬・透析のように一つずつの処置に降ろし、心停止が起きる前に本人の価値観に照らして話します。生理学的に無益なCPRを「短時間だけ行う」ことも、誠実さも害の軽減も満たさない妥協だと論じ

られています [Wasserman CritCare2026]。4学会GLも、適切なプロセスで終了・差し控えを選んだ後に苦痛を伴う心停止時の蘇生を行うことは推奨しないとしています（Q38） [4学会GL2026]。

5-5. 抗菌薬・人工栄養・ペースメーカーも、何のために使っているかで一つずつ決める

症状緩和に使っている強心薬は必ずしも減らさず、人工栄養やペースメーカーも生命維持治療になりうるものとして同じ手順で判断し、終末期の抗菌薬は感染部位ごとに症状緩和になっているかで決めます（表16） [4学会GL2026] [Correia ICM2026]。

表16 | 個別の治療の考え方 — 一律に止めず、目的で決める

治療	考え方
心不全の苦痛緩和に使っていた強心薬	症状の強さと必要性で増減する。必ずしも減量・終了は要らない（Q40）
ペースメーカー・ICD	依存していれば事実上の生命維持治療。ICDの除細動機能は循環器内科医と相談して停止を検討（Q41・別編）
人工栄養	胃ろうを含め生命維持治療の一つ。行わない場合も口腔ケア・食事介助・苦痛緩和は続ける（Q44）
終末期の抗菌薬	死亡直前の40～80%に投与されているが、症状緩和は21.4～56.7%と一貫しない。尿路感染は60～92%、呼吸器感染は0～53%と部位で桁が違う
機械的補助循環	対象に含まれ、同じ手順で決める。日本では経験施設が非常に少ない（6-5）

抗菌薬を始めるなら、開始時に「48～72時間後に経過・培養・予後で再評価し、改善がなければやめる」と書きます。「もう1コース」が本人の症状ではなく医療者と家族の不安を治療しているなら、それは適応外の投与です [Correia ICM2026]。

5-6. 記録には「考慮した時期の根拠」と「検討に加わった全員」を残す

4学会GLは、説明の対象と内容・理解・同席者、本人の意思と推定意思の根拠、終了・差し控えを考慮する時期であることの根拠、検討に加わったすべてのメンバーを診療記録に残すよう求めています（表17） [4学会GL2026]。

表17 | 診療記録に書く項目 — のちの検証に耐える書き方

区分	記載する事項
医学的な検討とその説明	説明の対象となる本人・家族等とその範囲／説明した内容／理解や受容の状況／同席した医療・ケア従事者
本人の意思	本人の意思、またはACPの記録に示された意思と、それが述べられた状況／それがなければ家族等による推定意思とその根拠
終了・差し控えを検討する際の対応	本人の意思またはACPの内容／推定意思とその根拠／家族等の意向／考慮する時期であることとその根拠／最善のゴールの検討内容／検討に加わったすべてのメンバー

一般的な説明の記録で抜けやすいのは、「考慮する時期とその根拠」「検討に加わった全員」「説明に同席した医療・ケア従事者」「推定意思の根拠」です。意思は変わりうるので、話し合いはそのたびに記録します [4学会GL2026]。

§6 緩和的抜管 — 準備を済ませ、苦痛に先回りし、そばにいる

終了で最も多いのは人工呼吸器の終了です。4学会GLの緩和ケア別編は、止めるもの、抜管の方法、抜管の前後の薬と量まで示しました。適切な緩和ケアを提供できない状態で終了・差し控えを行うべきではない、というのが本編の原則です。

この章のポイント

- 1 経管栄養は24時間前、筋弛緩薬は2時間前に止める
- 2 オピオイドはボーラスで、上限を設けずに使う
- 3 苦痛が落ち着くまで、医師と看護師はベッドサイドを離れない

6-1. 緩和ケアは予後ではなく必要性で — 終了の前から始めている

緩和ケアは予後ではなく必要性に基づくもので、主治医と担当看護師が行う基本的緩和ケア（症状緩和・意思決定支援・心理社会的支援）を救急搬送やICU入室の早期から提供し、終了の後に導入するのでは遅すぎます [Edwards ICM2016] [4学会GL2026]。

救命治療と苦痛の軽減は対立するものではなく両輪です（Q57・Q58）。担い手はICUの臨床医全員で、専門の緩和ケアチームは緩和しにくい苦痛や意思決定の困難があるときの上乗せです [Edwards ICM2016]。敗血症の診療ガイドラインも、ゴール・オブ・ケアの話し合いやTLT、緩和ケアを良い実践として初めて明記し、治療の目標が相によって変わることを示しました [Kesecioglu ICM2026]。

× 危険 — 準備なしに終了しない

侵襲的な治療を終えても症状緩和の治療は最大限続くため、適切な緩和ケアを提供できない状態で生命維持治療の終了・差し控えを行うべきではありません [4学会GL2026]。

6-2. 抜管の前日から、止めるものと時刻を逆算する

経管栄養は24時間前まで、筋弛緩薬は2時間前まで（多臓器不全では18時間前まで）に止めるのが望ましく、透析・昇圧薬・抗菌薬・輸血・身体拘束は終了し、ラインやモニターや検査は苦痛と利益を比べて一つずつ決めます（図6・表18） [4学会GL2026 別編]。



図の読み方 — 左から右へ時間が進みます。経管栄養と筋弛緩薬の終了、抜管後にそばにいることは全員に、12時間前・30分前・直前の投与は上気道浮腫・分泌物・苦痛の出方を予想して患者ごとに検討します [4学会GL2026 別編]。筋弛緩薬が残っていると苦痛を評価できず、鎮痛を調整できません。

表18 | 止めるものと、止めるかを検討するもの — 観るのは数値ではなく、表情と家族の反応

区分	項目	注意点
終了する	透析、経管栄養、昇圧薬、抗 菌薬、輸血、筋弛緩薬、身体 拘束	家族等と十分に話して決める
終了を検討する (装置)	機械的循環補助、ペースメー カー、ICDの除細動機能	ICDは循環器内科医と相談して除細動機能を停止
終了を検討する (ライン・モニタ ー)	中心静脈・動脈ライン、心電 図モニター、パルスオキシメ ーター	末梢がなければ中心静脈は投与路に残してよい。モニターは外 してもよく、付けるならアラームを切る。外させないための身 体拘束はしない
終了を検討する (ケア・検査)	バイタル測定、輸液、体位変 換、血液検査、X線・CT	輸液は浮腫・胸水・せん妄につながる。家族に分かりやすく説 明する

実施の前には、十分な話し合いで決めたこと、ゴールが症状緩和優先であること、心停止時に蘇生しないこと、抜管後に再挿管しないことを医療者の間で再確認します [4学会GL2026 別編]。モニターを外すか残すかは、一律にせず家族に選んでもらうのが安全です。消したことで最期の喘ぎに驚いた家族と、消してもらえずモニターを見て崩れた家族が、同じ研究の中に並んでいました [Kentish-Barnes ICM2026]。

6-3. 抜管は段階的離脱か即時抜管 — 死亡までは数分から数日と伝える

高度の呼吸サポートが要る呼吸不全では15～30分かけて設定を下げる段階的離脱、意識障害の患者では準備のうえ設定を下げずに抜管する即時抜管が多く選ばれ、抜管から死亡までの中央値は0.9時間（海外の報告）ですが数時間～数日の例もあります

段階的離脱 (gradual weaning)

- 15～30分かけて設定を下げ、できるだけ自発呼吸へ移す
- 麻薬・鎮痛薬を適量投与しながら行い、その後には抜管する
- 高度のサポートが要る呼吸不全で多い

即時抜管 (immediate extubation)

- 設定を下げずに抜管する
- 鎮静・鎮痛の準備を済ませてから行う
- 脳神経疾患などの意識障害で多い

家族には不確実さを持たせて説明し、状態が変わるたびに伝えます。死戦期呼吸・死後の筋の攣縮・「思ったより長くかかること」を先に言葉にしておく、死の徴候を読み取れない苦しさを減らせます [Kentish-Barnes ICM2026]。浮腫・外傷・腫瘍で気道閉塞のリスクが高ければ、人工呼吸は終えても気管チューブは残す選択肢があります [4学会GL2026 別編]。

6-4. 薬はボーラスで効かせ、オピオイドに上限を設けない

呼吸困難と痛みにはオピオイドが最も有効とされ、効果が早く蓄積しにくい「ボーラス・ファースト」で、オピオイド未投与ならモルヒネ2～5 mgから始め、効果がある限り症状が緩和されるまで増やし、用量の上限は設けません (表19) [4学会GL2026 別編]。

表19 | 抜管の前後の薬の目安 — 持続投与中なら、直近の量を基準に上乘せ

場面	モルヒネ	フェンタニル	ミダゾラム
未投与の初回	2～5 mg 静注・皮下。高齢・衰弱ではさらに少なく	20～50 μg。安全域が狭いので少量ずつ	0.01～0.06 mg/kgを1分以上かけて
持続中の抜管直前	直近の効果量の2倍をボーラス	直近1時間量の25～50%をボーラス	持続の1時間量をボーラス
持続なしの抜管直前 (例)	5分前に5 mg	5分前に25～100 μg	5分前に2～4 mg
抜管後に苦しそうなとき	10～15分ごとに追加	5～10分ごとに追加	5～10分ごとに追加
頻回にボーラスが要るとき	持続中なら速度を25～50%増やす。持続していなければ持続を始める (効いたボーラス量の半分の時間量から。例：モルヒネ2 mgで緩和したら1 mg/時)		

表は一例で、体重・年齢・病状・臓器障害で調整します。緩和ケア別編の薬の表は米国救急医学レジデント協会の実務記事を改変したもので、日本の用量の根拠ではありません。全量・その他の症状の薬は解説ページの§5と原典「4学会合同ガイドライン (2026) 緩和ケア別編」の表1・表2で確認してください [4学会GL2026 別編]。

鎮静薬は本来、症状緩和薬を使っても抑えられないときだけ使うものですが、ベンゾジアゼピンは不安やせん妄の症状緩和薬でもあるため、実際には最初から併用されることが多いとされます。予想に反して長く生存し状態が安定したら減量も含めて調整し、死亡まで機械的に鎮静を続けません [4学会GL2026 別編]。

10のガイドライン・コンセンサス声明を統合した系統的レビューも、質の高いエビデンスがないにもかかわらず、定量的な疼痛評価、疼痛にはオピオイド・不安にはベンゾジアゼピン、終了時に筋弛緩薬を残さない、上限用量を設けない、の点で推奨が一致していました（表20） [Durán-Crane CCM2019]。症状管理のための増量という意図は、滴定のたびの記録で示します。これが症状緩和と死期の短縮を分ける境界線です。

表20 | 終末期の疼痛管理で10文献が一致した5点 — 根拠は統計より倫理と合意

一致点	内容
疼痛評価	行動観察スケールを含む定量ツールで継続的に評価する
薬の選択	疼痛には麻薬性鎮痛薬、不安にはベンゾジアゼピン
筋弛緩薬	終了時に効果を残さない。苦しんでいても外から分からなくなる
用量の上限	望む効果か耐えがたい副作用が出るまで増量する。最大用量は設けない
質の指標	定量評価スケールを終末期の疼痛管理の質の指標に使う

6-5. 症状ごとの初手 — 分泌物は浅く吸い、不安をオピオイドで眠らせない

不安にはミダゾラム、過活動型せん妄には抗精神病薬、気道分泌物には体位の工夫と輸液の減量、上気道狭窄には抜管前のカフリークテストが別編の初手で、不安やせん妄に鎮静目的でオピオイドを使うことは推奨されません（図7） [4学会GL2026 別編]。

症状ごとの初手

呼吸困難・痛み	→	オピオイドのボラス。不十分なら10～15分ごとに追加か、持続を足す
不安	→	ミダゾラム（効きが早く短い）。不安は呼吸困難と強く関連する
過活動型せん妄	→	抗精神病薬（またはベンゾジアゼピン）
気道分泌物（死前喘鳴）	→	体位と輸液の減量。抗コリン薬は選択肢。家族への説明を必ず添える
上気道の狭窄	→	抜管前にカフリークテスト。ハイリスクなら予防的ステロイドか、チューブを残す

しないこと

不安・せん妄にオピオイド	→	鎮静目的のオピオイドは推奨されない
深い吸引	→	出血や咽頭反射を誘発する。口腔内など浅い部分を愛護的に
筋弛緩薬を残す	→	苦痛を評価できず、鎮痛を調整できない

抗コリン薬には口渇・尿閉・せん妄の悪化などの副作用があり、意識が清明な患者では注意する

図7. 症状ごとの初手としないこと — 予測して先に手を打つ。

図の読み方 — 上の5段が症状ごとの最初の一手、下の赤い3段がしないことです [4学会GL2026 別編]。死前喘鳴は本人の苦痛ではないとする見解もありますが、そばにいる家族の苦痛になることが多く、説明そのものが初手の一部です。意思表示できない患者の呼吸困難は、日本語版RDOS（心拍数・呼吸回数・落ち着きのなさ・奇異呼吸・補助呼吸筋・呻吟・鼻翼呼吸・苦悶表情の8項目）を補助に、表情・仕草・家族の評価を加えて判断します。

ECMOなどの機械的補助循環の終了は、日本では経験施設が非常に少なく、実際にはIMPELLAやLVADの血栓閉塞、ECMOの人工肺の機能低下が終了の条件になっています。別編はTLTを当てはめ、期間内にゴールを達成できないと考えられたときに終了を検討するよう勧めています [4学会GL2026 別編]。ECMOの看取りを、準備・薬のタイミング・機器操作のばらつきが苦痛を生む「低頻度・高リスクの手技」として、4相モデルとチェックリストで標準化する提案もあります（実証データはなく専門家意見）

[Hubel Healthcare2026]。この提案の要点は、VA-ECMOでは流量を下げる前に苦痛緩和薬を入れること（流量0では薬が回らない）と、VV-ECMOでは血流を保ったままスweepを段階的に0へ下げることです。VV-ECMOの管理は[VV-ECMO 実戦管理ガイド](#)で扱います。

§7 看取りと死別 — 家族の時間を守り、告知と依頼を分ける

終了を決めた後から死別の後まで、家族のケアは続きます。この章では、時期ごとの家族のケア、死の判定を伝える言葉、臓器提供の話の順序を見ます。どれも、家族に残る記憶を左右する場面です。

この章のポイント

- 1 家族のケアは話し合いの前から死別後まで6つの時期で考える
- 2 死亡確認と脳死の説明は「判断した」と言う
- 3 治療終了の決定が先、臓器提供の話は後に分ける

7-1. 家族のケアは6つの時期で — 亡くなった後の面談まで含める

ICUや救急外来での死別は悲嘆を長引かせるリスクが高いため、4学会GLの緩和ケア別編は家族のケアを、話し合いの前・間・後、終了前、臨終時、死別後の6つの時期に分けて示しています（図8） [4学会GL2026 別編]。



図の読み方 — 左から時間が進みます [4学会GL2026 別編]。右端の死別後の関わりは、3ステップ支援で対照群と最も差が開いた部分（死後の面談 29% vs 85%）にあたります（4-5） [Kentish-Barnes Lancet2022]。

表21 | 残された時間のケアの例 — その人らしさと、家族とのつながりを支える

種類	例（4学会GL2026 緩和ケア別編）
本人を尊重するケア	好きな衣服・帽子・枕、好きな音楽やアロマ、入浴・洗髪・マッサージ、思い出の写真、誕生日や記念日のお祝い、好きな飲み物を味わう、口腔ケアと保湿
家族とのつながり	面会のルールを柔軟に、電話やビデオ通話、家族への手紙づくりの支援、保清への家族の参加（顔への送風で呼吸困難が和らぐことがあると伝え、家族から風を送ってもらう）
死後を見すえたケア	希望があれば集合写真、手形や髪の一部を形見に、遺言・葬儀などの気がかりを専門家へつなぐ

立ち会いを望まない家族には一度退室してもらい、苦痛が抑えられたのを確かめてから入室してもらいます [4学会GL2026 別編]。遺体との対面は独立した場面として扱い、準備の説明と付き添いを置きます。冷たさ・硬さ・においが記憶に残り続けると語られています [Kentish-Barnes ICM2026]。面会のルールは希望に応じて柔軟にします。家族中心のケアのガイドラインで強い推奨は面会の緩和の1つだけでした [Hwang CCM2025]。人間的なケア全般はICUの**人間的ケア**、生存者と家族の退室後は**PICSとICU退室後のフォロー**で扱います。

7-2. 死亡確認で確かめているのは「もう戻さない」という決定 — permanence

蘇生を止めて死亡を確認するとき、確かめているのはどんな手段でも戻せないこと（irreversibility）ではなく、循環を回復させないという私たちの決定に支えられた永続性（permanence）で、死の判定は基準の機械的な適用ではなく臨床判断です（表22） [Le Dorze CritCare2026]。

表22 | 死の判定を読むための言葉 — 2つの「戻らない」を区別する

用語	意味	例
permanent（永続的）	自然には再開せず、介入によっても回復させないと決めた機能停止	蘇生を中止した心停止患者の脳機能
irreversible（不可逆的）	利用可能なあらゆる手段でも回復させられない機能停止	心停止中の脳機能は直接観察できず、この閾値は同定できない
performative（遂行的）	発話そのものが現実をつくる行為	「死亡を確認しました」という宣告が、患者を医学的・法的・社会的に死者へ変える
no-touch時間	循環停止の確認後、自己心拍再開が起きないことを確かめる待機時間	長さは法域で異なる

脳死の説明では「検査で証明されました」ではなく「複数の所見を突き合わせて判断しました」と言います。補助検査が見ているのは脳灌流や電気活動という代替の指標で、心臓が拍動し皮膚が温かいままの体を前にした家族には、神経学的基準による死は直感に反しうるからです [Le Dorze CritCare2026]。死亡確認での無呼吸・無循環の観察時間は手順書に明記し、暗黙知にしません。

7-3. 臓器提供は、治療終了の決定の後に独立した話として — 告知と依頼を分ける

臓器提供の可能性が終了の判断に影響してはならず、方針が整理された後に独立したプロセスとして提示し、死亡告知と提供の依頼を**同じ面談枠に続けて入れないこと（decoupling）が家族を守ります** [4学会GL2026 Q79] [Choi CritCare2026]。

4学会GLは、脳死とされうる状態での脳死下臓器提供は終了・差し控えの意思決定と切り離せないのと同じ多職種検討とSDMの手順で話し合い、心停止後臓器提供は終了・差し控えの意思決定が示された後に専門家の慎重な判断のもとで検討するとしています。提示しないことも、情報に基づいて決める機会を損ないます [4学会GL2026]。28本の質的研究の統合は、脳死後提供と心停止後提供では家族の苦悩の質が違うことを示しました（表23） [Choi CritCare2026]。

表23 | 脳死後提供（DBD）と心停止後提供（DCD）の家族の体験 — 同じ「提供」でも経験は別物

次元	DBDの家族	DCDの家族
目にするもの	宣告されたのに生きているように見える体（温かさ・色つや）	死んでいく過程そのもの（治療終了と心機能の停止）
時間の感覚	宙ぶりの時間。宣告と実感の不協和	時間の圧縮。臓器の時間枠が別れの時間を切り詰める
道徳的な重み	「本当に死んでいる」証拠を求める認知の作業	「死のタイミングに関わった」という決定の残滓

家族を最も傷つけていたのは、臨床医の態度より、告知と依頼を続けて行う手順や、臓器を一つずつ確認させる同意書、書類の山といった制度の設計でした [Choi CritCare2026]。患者を臓器の供給源ではなく一人の人として扱い、話しかけ続けた臨床医が、家族に安心を与えていました。臓器提供の有無で終末期ケアの中身を変えないことも、提供を前提にした看取りの原則です [Oppenheim CritCareExplor2026]。

§8 チームを守る — モラルディストレスは個人の耐性ではなく組織の課題

「無益な治療が続けている」という痛みは、研修や個人の頑張りでは解決しません。この章では、モラルディストレスを生む施設の要因と、組織として先に変えるべきことを見ます。

この章のポイント

- 1 モラルディストレスを施設の要因から読む
- 2 研修より先に、権限と手続きを変える
- 3 デブリーフィングは予防ではなく緩和と知る

8-1. モラルディストレスを増やすのは、文化・階層・手続きの不在

米国4学術病院の122人の面接は、モラルディストレスを増やす施設の要因として、医療消費主義を受け入れる病院文化、医療の階層、治療を縮小するための手続きの不在を名指しました（表24） [Brender JAMANetwOpen2025]。

表24 | モラルディストレスの施設要因 — 個人ではなく組織の問題

増やす要因	和らげる要因
医療消費主義を受け入れる病院文化	階層を越えて臨床医に権限を与える方針（看護師が単独で緩和ケア・倫理コンサルを依頼できる）
医療の階層（主科と専門科のコンサルタントの力関係を含む）	対立の処理と情緒的支援の資源（緩和ケアチーム・death rounds など）
治療を縮小する手続きの不在	現場発の改善と支持的な管理職（家族面談への看護師の同席を必須にする など）

モラルディストレスは、正しいと信じるのが他者の価値観や組織の制約で実行できないときの不満・怒り・失望で、特に看護師が経験しやすく、同じ場面が来るたびに上乗せされて残ります（moral residue） [4学会GL2026 別編]。別編は、終了・差し控えに関わる医療者に起こりうる心理的な負担を5つに整理しています（表25）。

表25 | 医療者に起こりうる心理的負担（4学会GL2026 緩和ケア別編） — 名前が付くと、組織で扱える

負担	特徴
モラルディストレス	正しいと信じるのが他者の価値観や組織の制約で実行できないときの不満・怒り・失望。看護師が経験しやすい
共感疲労	共感がケアの原動力になる一方、甲斐なく死や悪化を繰り返し経験して無力感に陥る
PTSD・急性ストレス症	侵入・覚醒・回避・認知と気分の陰性変化。曝露から1か月以内なら急性ストレス症
二次的外傷性ストレス	心的外傷を直接経験していない支援者が、PTSDと同様の反応を示す
バーンアウト	職場環境・人間関係・過剰な業務が続いて起こる。疲弊→シニシズム→職務効力感の低下

ICU看護師の34研究を統合した系統的レビューでも、上位の要因は無益と感じる延命治療と不要な検査・処置の実施でした（統計処理に疑義があるためプール値は使わない） [Qu BMCNurs2026]。

8-2. 先に変えるのは権限と手続き、デブリーフィングはその次

効いたのは役割の新設ではなく権限と手続きの変更で、デブリーフィングは起きた苦痛を和らげる「緩和」であって「予防」ではないため、順番を逆にしません [Brender JAMANetwOpen2025]。

組織として変える順番

- 1 看護師が単独で倫理・緩和ケアコンサルを依頼できる権限を明文化する
- 2 家族面談への看護師の同席を、実際の割合を測ってから必須にする
- 3 治療の終了条件を説明と同意の段階で書面に残す（TLTの目標・期日）
- 4 困難な事例の後に、短いデブリーフィングを定例にする
- 5 スタッフの心理状態を定期的にスクリーニングする（日本語版MMD-HPなど）

新しい役割を作るなら、その担い手のモラルディストレスも見込みます。看護師ファシリテーターの研究では、部門長の支持の有無、役割の曖昧さ、既存職種との縄張りが実装を阻み、担い手自身が「家族の前で本当に一人」と孤立を語っていました [Renet ICM2024]。4学会GLの緩和ケア別編も、人員配置と仕事量の管理、デブリーフィング、定期的なスクリーニング、外部チームと連携した相談体制を組織的支援として挙げています [4学会GL2026 別編]。医療者の判断のずれそのものはICUの判断はなぜ外れるかで扱います。

§9 落とし穴 — 良い意図が、言葉と順番の誤りで害に変わる

ここまでの原則は、実際には一つずつではなく組み合わせあって崩れます。よくある誤りを、なぜ起きるかどう防ぐかで並べます。

！① DNARを理由に、心停止前の治療を自動的に控える

様式に範囲が書かれておらず、「もう積極的にはやらない」の省略語として流通しているために起きます。DNARで決まるのは心停止時の蘇生だけで、挿管・昇圧薬・ICU入室は別に話し合います（2-1） [日本救急医学会2025] [4学会GL2026 Q37]。

！② 「やめられないから始めない」

終了への法的・心理的な不安から、救えたかもしれない治療を最初から差し控えます。差し控えと終了は倫理的に同等で、迷ったらTLTで始めて期日に見直します（5-1・5-3） [4学会GL2026 Q33]。

！③ 「すべてやりますか」と聞き、スローコードに逃げる

二択が家族にとって苦しく、その逃げ道になります。心停止の前に処置ごとに話し、形だけの蘇生は選択肢から外します（5-4） [Fontenot CCM2026]。

！④ 悪い知らせの直後に「どうされますか」と決定を求める

沈黙や怒りは理解の悪さではなく生理的な過負荷です。その場で決めさせず、翌日もう一度話します（4-1）

[Rusinova ICM2026]。

！⑤ 「決めたのはご家族です」と言う

決定の重荷が家族に残ります。医学的に到達した結論を家族と確認した、という言い方と記録にします（4-3）

[Kentish-Barnes ICM2026]。

！⑥ 「偽陽性ゼロ」や重症度スコアを、治療制限の根拠にする

予測は情報、決定は価値観です。分母の小さい「ゼロ」は「10人に1人まで外れうる」と伝えます（3-4） [Xu CritCare2026]

[Bein ICM2023]。

！⑦ 「この人はどうせQOLが低い」を前提に置く

障害・高齢・認知症を、能力の欠如や治療の無益に短絡させます。本人に聞き、補助具を試し、同じ基準を当てます（3-6）

[Taccone ICM2023]。

！⑧ 筋弛緩薬を残したまま、薬の準備なしに抜管する

苦しんでいても外から分からなくなります。筋弛緩薬は2時間前（多臓器不全では18時間前）までに止め、苦痛に先回りし、落ち着くまでそばにいます（6-2・6-4） [4学会GL2026 別編]。

！⑨ 「BSCで」「ここからは緩和で」と言って手を引く

中身が見えず「見放された」と受け取られます。何を続け、何をやめ、どう苦痛を取るかを具体的に伝えます（2-2）

[4学会GL2026 説明文]。

！⑩ 死亡告知と手続きの依頼を、同じ面談で畳みかける

一度に済ませたほうが効率的に見えるため起きます。告知と依頼の間に時間を置き、担当を分けます（7-3）

[Choi CritCare2026]。

主要文献

本文中の〔 〕は出典です（ガイドライン・原著論文・総説）。4学会GL2026は下の1の各分冊（本編・説明文・Q&A集・緩和ケア別編）を指し、Q番号はQ&A集の問いの番号です。文献は、ガイドラインと用語、決め方、話し方と家族支援、選択肢と緩和的抜管、看取りと死の判定、チームのケアの順に並べています。

1. 日本集中治療医学会・日本救急医学会・日本循環器学会・日本緩和医療学会 編. 救急・集中治療における生命維持治療の終了／差し控えに関する4学会合同ガイドライン（本編・説明文・Q&A集・緩和ケア別編）. 令和8年9月.
2. 日本集中治療医学会・日本救急医学会・日本循環器学会. 救急・集中治療における終末期医療に関するガイドライン ～3学会からの提言～. 2014.
3. 厚生労働省. 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン（解説編）. 平成30年3月.
4. 会田薫子, 小豆畑丈夫, 新井隆男, ほか（日本救急医学会 高齢者救急委員会）. 日本救急医学会 高齢者救急に関する用語の統一概念. 日救急医学会誌. 2025;36:82-90.
5. 日本集中治療医学会 倫理委員会. DNAR指示のあり方についての勧告. 日集中医誌. 2017;24:210-215.
6. Secunda K, Wirpsa MJ, Neely KJ, et al. Use and Meaning of "Goals of Care" in the Healthcare Literature. J Gen Intern Med. 2020;35(5):1559-1566.
7. Khayat Kakhki S, Daneshfar M, NamaeiQasemnia A, et al. Reimagining resuscitation ethics: a narrative review and emergent ethical pathways model. Resusc Plus. 2026;29:101323.
8. Sprung CL, Ricou B, Hartog CS, et al. Changes in End-of-Life Practices in European Intensive Care Units From 1999 to 2016 (Ethicus-2) . JAMA. 2019.
9. 伊藤香. 緩和的抜管. 人工呼吸（Jpn J Respir Care）. 2023;40(2):120-125.
10. Ganzini L, Volicer L, Nelson WA, Fox E, Derse AR. Ten Myths About Decision-Making Capacity. J Am Med Dir Assoc. 2004;5:263-267.
11. Tarcy T, Kallel H, Giffard M, Besch G, Aubry R. Decision-making process during limitation life-sustaining support meetings in French intensive care units. Intensive Care Med. 2022.
12. Bein T. Avoidance of futile treatment—confluence of human dignity and ecological ethics. Intensive Care Med. 2023;49(9):1145-1146.
13. Xu LX. Neuroprognostication after cardiac arrest: time-anchored reassessment and uncertainty around zero false positives. Crit Care. 2026;30:441.
14. Hesselink G, Ramakers B, Fikkers BG, et al. (PICNL-ICU Study Group) . Crit Care Med. 2026;54.

15. Taccone FS. Ableism in the intensive care unit. *Intensive Care Med.* 2023;49(7):898-899.
16. Gerhart KA, Koziol-McLain J, Lowenstein SR, Whiteneck GG. Quality of life following spinal cord injury: knowledge and attitudes of emergency care providers. *Ann Emerg Med.* 1994;23(4):807-812.
17. Albrecht GL, Devlieger PJ. The disability paradox: high quality of life against all odds. *Soc Sci Med.* 1999;48(8):977-988.
18. Jabaley CS, Brummell Z, Benoit DD, Kentish-Barnes N, Metaxa V. Conflict in intensive care units: a conceptual framework. *Crit Care.* 2026.
19. Rusinova K, Rusina R, Pantilat SZ. Understanding the neuroscience of communicating serious news. *Intensive Care Med.* 2026.
20. Lu E, Nakagawa S. A "three-stage protocol" for serious illness conversations: reframing communication in real time. *Mayo Clin Proc.* 2020;95(8):1589-1593.
21. Kentish-Barnes N, Poujol AL, Banse E, et al. Giving a voice to patients at high risk of dying in the intensive care unit. *Intensive Care Med.* 2023;49(7):808-819.
22. Maringer EF, Shiland J, Brodie D. *Intensive Care Med.* 2018;44(6):930-931 (ECMOの夫に付き添った妻の記録) .
23. Kentish-Barnes N, Denise T, Renet A, et al. *Intensive Care Med.* 2026;52:1458-1471 (PTSD症状のある家族17人の質的研究) .
24. Ashana DC, Cox CE. ICU communication: "state of the art". *Intensive Care Med.* 2026;52(6):1333-1335.
25. Cox CE, et al. Trajectories of palliative care needs among family members of chronically critically ill patients. *Crit Care Med.* 2023;51(1):13-24.
26. Tuinman PR, Metaxa V. ICU toolbox: negotiation skills for family conversations in the ICU. *Intensive Care Med.* 2026.
27. White DB, Angus DC, Shields AM, et al. A Randomized Trial of a Family-Support Intervention in Intensive Care Units (PARTNER) . *N Engl J Med.* 2018;378(25):2365-2375.
28. Creutzfeldt CJ, Brumback LC, Im J, et al. Facilitating Communication for Family Members of Critically Ill Patients. *Crit Care Med.* 2026;54.
29. Li Z, Lu F, Abshire Saylor M, et al. Characteristics and Effectiveness of Nurse-Led Family Communication Interventions in the ICU. *Crit Care Med.* 2026;54(2):301-311.
30. Kentish-Barnes N, Chevret S, Valade S, et al. A three-step support strategy for relatives of patients dying in the intensive care unit: a cluster randomised trial. *Lancet.* 2022;399:656-664.
31. Quill TE, Holloway R. Time-Limited Trials Near the End of Life. *JAMA.* 2011;306(13):1483-1484.
32. Kruser JM, Ashana DC, Courtright KR, et al. Defining the Time-limited Trial for Patients with Critical Illness: An Official American Thoracic Society Workshop Report. *Ann Am Thorac Soc.* 2024;21:187-199.
33. Fontenot T, Grisel B, Freeman J, et al. Ethical Implications of the Slow Code: A Systematic Review. *Crit Care Med.* 2026;54.
34. Ajzenberg H, Oczkowski SJW. Slow Codes—It's Time for an Honest Approach. *Crit Care Med.* 2026;54.
35. Wasserman JA, Crutchfield P. Time-limited trials are not an ethical compromise for physiologically futile CPR. *Crit Care.* 2026. doi:10.1186/s13054-026-06329-7
36. Correia I, Gonçalves Pereira J, Metaxa V. Antibiotics must be part of end-of-life decisions: a necessary evil? *Intensive Care Med.* 2026.
37. Edwards JD, Voigt LP, Nelson JE. Ten key points about ICU palliative care. *Intensive Care Med.* 2016.
38. Kesecioglu J, Metaxa V, Azoulay E. Surviving Sepsis Campaign beyond survival: aligning sepsis care with patient goals. *Intensive Care Med.* 2026.
39. Kesecioglu J, Rusinova K, Alampi D, et al. ESICM guidelines on end of life and palliative care in the ICU. *Intensive Care Med.* 2024;50:1740-1766.

40. Downar J, Delaney JW, Hawryluck L, et al. Guidelines for the withdrawal of life-sustaining measures. *Intensive Care Med.* 2016;42:1003-1017.
41. Cooke CR, Hotchkin DL, Engelberg RA, et al. Predictors of time to death after terminal withdrawal of mechanical ventilation in the ICU. *Chest.* 2010;138:289-297.
42. Durán-Crane A, Laserna A, López-Olivo MA, et al. Clinical practice guidelines and consensus statements about pain management in critically ill end-of-life patients: a systematic review. *Crit Care Med.* 2019;47(11):1619-1626.
43. Sakuramoto H, Hatozaki C, Unoki T, et al. Translation, reliability, and validity of Japanese version of the Respiratory Distress Observation Scale. *PLoS One.* 2021;16:e0255991.
44. Egawa S, Ader J, Claassen J. Recovery of consciousness after acute brain injury: a narrative review. *J Intensive Care.* 2024. doi:10.1186/s40560-024-00749-9.
45. Hubel K, Reddy R, Khan A, Pak J, Sher N. Compassionate Extracorporeal Membrane Oxygenation Discontinuation: A Narrative Review and Practical Process Model for Reliable End-of-Life Care. *Healthcare (Basel).* 2026;14:1249.
46. Hwang DY, Oczkowski SJW, Lewis K, et al. Society of Critical Care Medicine Guidelines on Family-Centered Care for Adult ICUs: 2024. *Crit Care Med.* 2025;53(2):e465-e482.
47. Le Dorze M, Nicolas-Robin A, Carvallo S, Maglio M, Molina-Pérez A. Death determination at the bedside: clinical judgement beyond criteria. *Crit Care.* 2026.
48. Choi HR, Zhu L, Lo MS, et al. Family members' experiences of death and organ donation in intensive and critical care units: a qualitative systematic review with thematic synthesis. *Crit Care.* 2026.
49. Oppenheim IM, Bakhru RN, Maciel CB, Busl KM; DONOR Group. *Crit Care Explor.* 2026;8(8):e1458 (心停止後臓器提供でも終末期ケアの質を変えない) .
50. Brender TD, Axelrod JK, Weiss Goitiandia S, Batten JN, Dzung EW. Clinicians' Perceptions About Institutional Factors in Moral Distress Related to Potentially Nonbeneficial Treatments. *JAMA Netw Open.* 2025;8(6):e2516089.
51. Qu KY, Zhu DJ, Yang PF, et al. Moral distress of intensive care unit nurses: a systematic review and meta-analysis. *BMC Nurs.* 2026;25:108.
52. Renet A, Azoulay E, Reignier J, et al. "It's all about setting the stage." The nurse facilitator trial: perceived outcomes and implementation issues. *Intensive Care Med.* 2024;50(10):1657-1667.
53. Fujii T, Katayama S, Miyazaki K, et al. Translation and validation of the Japanese version of the measure of moral distress for healthcare professionals. *Health Qual Life Outcomes.* 2021;19:120.